

RESUMEN DE ALIMENTACIÓN Y DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL EN PEDIATRÍA

Dr. Guillermo Guevara Aliaga

I. PNAC (Plan Nacional de Alimentación Complementaria)

El Estado entrega gratis (en estricto rigor, financiado por los contribuyentes) leches a niños menores de 6 años, embarazadas y mujeres en lactancia. El derecho es **universal** (no discrimina por nivel socioeconómico, nacionalidad, previsión).

Ha habido cambios en el último tiempo, buscando simplificar la preparación (ya no se requiere agregar azúcar, aceite o cereal a las fórmulas entregadas por el Minsal) y combatir la obesidad infantil (ej. leche descremada).

II. Alimentación por edad

1) Menor de 12 meses:

- **Lactancia materna exclusiva** (ideal).
- Alternativa: **Fórmula de inicio** Minsal (gratuita) y otras fórmulas de inicio (caras, se hacen siguiendo instrucciones de cada marca. Ejemplos: NAN1, S26).
- Se reemplazó a la leche purita fortificada, que se daba con LPF 7,5% (bajar carga osmótica) + aceite 2% (aportar ácidos grasos esenciales) + azúcar 3% (idealmente maltodextrina o sacarosa, para agregar calorías). En cambio, la fórmula de inicio solo requiere agua.
- A los 6 meses: agregar primera comida (sopa puré de vegetales con carne o pollo). Puede ser a los 5 meses si está con fórmula.
- A los 8 meses: agregar segunda comida.
- Todas las comidas, salvo la miel, se pueden iniciar a los 6 meses.
 - o Algunas guías sugieren otras edades de inicio (sin evidencia): pescado (6-7 m), huevo (9-10 m), legumbres (8 m).
 - o No tiene mayor relevancia si hay antecedentes familiares de alergia o enfermedad celiaca.
 - o **Miel**: iniciar después de los **12 meses (riesgo de botulismo)**.
 - o Nunca dar azúcar, endulzantes, dulces ni bebidas azucaradas a los niños.
- Al agregar una comida, se debe eliminar una leche.

2) Mayor de 12 meses:

- **Lactancia materna o fórmula de continuación:**
 - o Leche Purita + Pro 1 (12 a 24 meses)
 - o Leche Purita + Pro 2 (24 meses a 6 años)
 - o Se reemplazó a la leche purita cereal (LPC 7,5% o 10%).
- Alternativa: leche de vaca común.
- Comidas similar a adulto.

III. Grupos especiales

- **Prematuros:** Solo aplica a los que nacen antes de las 32 semanas o con peso < 1.500 g.
 - Ideal sigue siendo la lactancia materna.
 - < 6 meses (edad corregida): Fórmula especial para prematuros (aceptable fórmula de inicio).
 - > 6 meses (edad corregida): fórmula de inicio y luego fórmula de continuación igual que en no prematuros. Se agrega comida ("Mi Sopita") hasta los 12 meses (edad corregida).
 - La edad corregida de los prematuros se calcula corrigiendo por la diferencia que hay hasta las 40 semanas. Ej. Si nació a las 28 semanas (12 semanas antes de las 40 semanas) y ahora tiene 4 meses, su edad corregida será de 1 mes.
- **Bajo peso y desnutrición:** Reciben mayor cantidad de leche, prefieren leche entera y reciben comida desde los 6 meses ("Mi Sopita").
- **Alergia a la proteína de leche de vaca (APLV):** Leche especial hipoalergénica (hidrolizada o de aminoácidos, según severidad).
- **Errores innatos del metabolismo** (ej. galactosemia, fenilcetonuria): Leche especial según el tipo de defecto metabólico (hay 26 fórmulas distintas).
- **Gestantes y mujeres en lactancia:** Leche purita mamá.

IV. Destete

Debe ser "respetuoso", no súbito, sino que dejando de ofrecer pecho (sí se sigue dando, pero ya no se ofrece) y se debe tratar de espaciar las tomas, hasta suspenderlas. No hay una edad para hacerlo, así que se puede hacer después del año, pero la OMS recomienda hacerlos después de los 2 años y la guía así lo reconoce.

V. Lactancia Materna

La leche materna es lo mejor que existe (previene muerte súbita, es excelente alimentación, protege de infecciones, etc.), pero le falta hierro. Incluso, si no puede amamantar (ej. vuelve al trabajo), se recomienda extraerse la leche y dar leche materna.

Contraindicaciones absolutas (muy pocas):

- VIH y HTLV (retrovirus).
- Algunos fármacos maternos: Quimioterapia, metotrexato.
- Drogas maternas (cocaína, heroína).
- Galactosemia (también contraindica la leche de vaca. Se debe alimentar con productos vegetales).

VI. Suplementos nutricionales

- Hierro: Entre los 4 y 12 meses. En prematuros inicia cuando duplican su peso de nacimiento (generalmente a los 2 meses; si cumple 2 meses, igual se inicia en prematuros). No es necesario si toma leches fortificadas (LPF o LPC por ejemplo).
- Vitaminas ACD (la única que realmente sirve es la vitamina D): Entre los 1 y 12 meses.

VII. Diagnóstico Nutricional

Este es un resumen de las tablas de Minsal en el diagnóstico nutricional pediátrico, para evitar cualquier tipo de confusión, ya que hay mucha información distinta, en las distintas fuentes:

¿Qué parámetro usar?

- Menores de 1 año: usar IP/T (índice peso talla o peso longitud) para sobrepeso y obesidad. Usar IP/E (índice peso edad) para desnutrición y riesgo de desnutrición.
- Mayores de 1 año: usar solo IP/T.
- Mayores de 5 años: usar solo IMC (índice de masa corporal). En algunas guías internacionales se usa desde los 2 años.

Interpretación

- Obesidad: desde +2 DS / p95. Se considera severa desde +3 DS.
- Sobrepeso: desde +1 DS / p85.
- Eutrofia: entre -0,9 y +0,9.
- Riesgo de desnutrición o bajo peso: desde -1 DS (con IMC se habla de bajo peso en el menor a p10) .
- Desnutrición: desde -2 DS.

VIII. Diagnóstico de talla

Se usa el índice talla edad (IT/E).

- Talla alta: mayor a +2 DS.
- Normal: -2 a +2 DS (acá sí se incluyen como normales los extremos, a diferencia del peso).
- Talla baja: menor a -2 DS.
 - Mayoría de niños con talla baja entre -2 y -3 DS son constitucionales.
 - Desde -3 DS suele ser talla baja patológica).
 - Siempre revisar curva de crecimiento.

Notas:

- Vale la pena mencionar que los percentiles p95 y p85 no calzan por las desviaciones estándar +2DS y +1DS, prefiriéndose las desviaciones estándar sobre los percentiles.
- Recordar ajustar edad en prematuros para el diagnóstico nutricional y de talla.